Siberkondri literat��r raporu

Çocuk GİS endoskopisi hastaları ve ebeveynlerinde siberkondri: literatür tarama raporu

Tarih: 12 Ekim 2026 Kapsam: Ebeveyn CSS-15 (siberkondri) + ebeveyn STAI-1/2 + çocuk Kısa Sağlık Anksiyetesi Envanteri (SHAI) + demografi + anestezi süresi ve ilaç dozu tasarımına benzer veya komşu yayınlar.

Güven etiketleri: [kesin] = PubMed meta verisi (PMID+DOI) ile doğrulandı; [doğrulanmalı] = yalnız Consensus/ClinicalTrials.gov kaydı veya özet kesik; [çıkarım] = benim yorumum.

0. Yöntem ve araç durumu

Araç	Durum	Kullanım
PubMed MCP (NLM E-utilities)	çalıştı	~100 sorgu, ~600 PMID meta veri doğrulaması (4 ajan + benim çapraz kontrolüm)
Consensus MCP	çalıştı	~25 doğal dil sorgusu; PubMed'de indekslenmeyen Türkçe/bölgesel dergiler için DOI kaynağı
ClinicalTrials.gov MCP	çalıştı	NCT05210829 doğrulaması
WebSearch	çalıştı	Türkçe ölçek uyarlamaları için
Elicit, Scite	**çalışmadı** (ücretli plan gerekiyor, API reddi)	—
Litmaps	bu oturumda yapılandırılmamış	—
WebFetch / curl (tam metin)	**sandbox'ta dış DNS kapalı**	Tam metin okunamadı; tüm bulgular özet + meta veri düzeyindedir

Sınırlılık: Tam metne erişemediğim için etki büyüklükleri özetlerde ne yazıyorsa odur. Özetinde kesik olan sonuçlar (örn. Erdoğan 2023 ketamin p değeri) tam metinden teyit edilmelidir.

1. Ana sonuç: boşluk haritası (yeniliğin kanıtı)

Kesişim	PubMed sonucu	Not
Siberkondri + ebeveyn + çocuk endoskopi/anestezi/sedasyon/cerrahi	**0**	Sorgu: cyberchondria AND (endoscopy OR anesthesia OR sedation OR surgery OR preoperative) → 17 kayıt, tümü erişkin hasta veya derleme [kesin]
CSS + STAI aynı örneklemde	**1** (Sezer 2022; 18–49 yaş kadın, ebeveyn değil, yalnız sürekli kaygı)	[kesin]
Ebeveyn siberkondrisi + çocuğun kendi sağlık anksiyetesi (SHAI/CIAS)	**0**	En yakın: Akgül 2021 (ebeveyn CSS → ergen genel anksiyete) [kesin]
Siberkondri ↔ anestezi süresi / ilaç dozu (herhangi popülasyon)	**0**	[kesin]
Çocuklarda endoskopi öncesi SHAI/HAI	**0**	Pediatrik endoskopide çocuk anksiyetesi mYPAS, SCAS, VAS, STAI-C, HADS(anne) ile ölçülmüş [kesin]
Ebeveyn STAI ↔ çocuk sedatif dozu, GİS endoskopisi	PubMed'de **0**; indekssiz **1** (Erdoğan 2023, J Health Sci Med)	[doğrulanmalı: Consensus+CT.gov]
Türkçe CSS-15 geçerlik/güvenirlik	**0** (PubMed, Consensus, WebSearch)	Bkz. §9
Türkçe SHAI/HAI pediatrik geçerlik	**0** (yalnız erişkin: Aydemir 2013)	Bkz. §9

[çıkarım] Çalışman üç eksende (ebeveyn CSS × STAI; ebeveyn CSS × çocuk SHAI; siberkondri × anestezi dozu/süresi) literatürde ilk olma iddiasını sorgu düzeyinde taşıyor. Ancak bu yenilik, ölçek geçerlik sorunlarıyla (§9) birlikte hakemde en çok sorgulanacak nokta.

2. Tasarımına en yakın çalışmalar (pediatrik endoskopi/sedasyon + anksiyete + doz/süre)

#	Kaynak	Tasarım / N	Ölçekler	Anestezi değişkeni	Ana bulgu	Etiket
2.1	**Erdoğan E, Tekin S, Polat E, Adıyeke E, Bakan N. 2023.** J Health Sci Med. DOI 10.32322/jhsm.1214850. Kayıt NCT05210829 (SBÜ, 20 Oca–20 Nis 2022)	Prospektif, tek merkez, Türkiye; 120 çocuk-ebeveyn, GİS endoskopisi	Ebeveyn STAI (yüksek ≥44), çocuk mYPAS	Midazolam, ketamin, propofol, fentanil dozları; KH	Ebeveynlerin %73'ü, çocukların %48'i yüksek anksiyeteli; %92 anne; yüksek anksiyeteli ebeveynlerin çocukları ve yüksek anksiyeteli çocuklar **daha fazla ketamin** gerektirdi (p değeri özette kesik)	[doğrulanmalı] PubMed'de yok
2.2	**Arıcan Ş ve ark. 2020.** J Surg Med. DOI 10.28982/josam.775935	Kesitsel, Türkiye; 104 çocuk 6–14 y, derin sedasyon endoskopi	Ebeveyn STAI-S/T, çocuk mYPAS (>30)	—	Ebeveyn anksiyetesi çocuk anksiyete grupları arasında **farksız**; çocuk anksiyetesi yaşla r=−0.589; yaş bağımsız risk (OR 0.501)	[doğrulanmalı] Consensus; Erdoğan'a karşı-bulgu
2.3	**Kara D ve ark. 2019.** JPGN 68(1):3-6. PMID 30169453. DOI 10.1097/MPG.0000000000002142	Prospektif, Erzurum; 119 çocuk EGD propofol + 85 kontrol	Çocuk mYPAS; tükürük kortizolü	Toplam propofol dozu; sedasyon/işlem/derlenme süresi	Anksiyete propofol dozu ve sedasyon/derlenme süresiyle pozitif, yaşla negatif korele	[kesin]
2.4	**Volkan B ve ark. 2019.** Saudi J Gastroenterol 25(4):262-7. PMID 31044746. DOI 10.4103/sjg.SJG_493_18	RKÇ, Erzurum; 184 çocuk gastroskopi	mYPAS; kortizol	Propofol dozu; süreler	Ayrıntılı bilgilendirme → daha düşük mYPAS, propofol dozu, sedasyon/endoskopi/derlenme süresi	[kesin]
2.5	**Mahajan L ve ark. 1998.** JPGN 27(2):161-5. PMID 9702646. DOI 10.1097/00005176-199808000-00006	RKÇ, ABD; 60 hasta 6–19 y	Çocuk STAI; OSBD	Meperidin mg/kg	Psikolojik hazırlık → STAI ↓ (p<0.0001), meperidin/kg ↓ (p≤0.04); ebeveyn öz-anksiyete ↓ (p=0.026)	[kesin] Klasik anksiyete→doz kanıtı
2.6	**Choi YJ ve ark. 2022.** Clin Child Psychol Psychiatry 27(3):793-803. PMID 35452583. DOI 10.1177/13591045221096308	Prospektif çok merkezli, Kore; <18 y EGD	SCAS	Midazolam dozu	İrritabl çocuklarda daha yüksek midazolam (p=0.006)	[kesin]
2.7	**Edalatkhah R ve ark. 2025.** J Pediatr Rev 13(2):145-50. DOI 10.32598/jpr.13.2.1185.1	İran; 50 çocuk 3–7 y UGE	Okul öncesi anksiyete ölçeği	Ek propofol, süre, derlenme	Anksiyete ↔ ek propofol (p<0.001), süre (p=0.027), derlenme (p=0.048)	[doğrulanmalı] Consensus
2.8	**Nouh FM ve ark. 2023.** Menoufia Nurs J. DOI 10.21608/menj.2023.322989	Yarı deneysel, Mısır; 80 çocuk+ebeveyn	Ebeveyn STAI, çocuk mYPAS, kortizol	Sedasyon/endoskopi/derlenme süresi	Video hazırlık → ebeveyn STAI 118.35→88.90; çocuk 75.66→40.20; süreler kısaldı	[doğrulanmalı] Consensus
2.9	**Çam S. 2021.** Gastroenterol Nurs 44(3):165-71. PMID 34037565. DOI 10.1097/SGA.0000000000000525	Prospektif, İstanbul; 101+101 çocuk 4–18 y + anne	Anne HADS; çocuk VAS	—	Anne HADS-A 3.83 (poliklinik) vs 6.96 (endoskopi), p<.001; endoskopi annelerinin ~yarısı HADS-A>8	[kesin]

#	Kaynak	Tasarım / N	Ölçekler	Anestezi değişkeni	Ana bulgu	Etiket
2.10	**Erel S ve ark. 2025.** Turk J Gastroenterol. PMID 40955499. DOI 10.5152/tjg.2025.25144	RKÇ, Gazi; 252 çocuk 3–17 y sedasyonlu endoskopi	Çocuk mYPAS; bakım veren APAIS	—	Broşür çocuk mYPAS'ı düşürdü; bakım veren APAIS farksız	[kesin]
2.11	**Teke H ve ark. 2025.** Pediatr Int 67(1):e70263. PMID 41246875. DOI 10.1111/ped.70263	Olgu-kontrol, Gülhane; 109 çocuk 8–17 y dispepsi, üst GİS endoskopi	K-SADS-PL, CDI, STAI-C	—	DGR grubunda anksiyete bozukluğu %40.7 vs %10.9	[kesin]
2.12	**YanYing P ve ark. 2023.** BMC Pediatr. PMID 37474961. DOI 10.1186/s12887-023-04187-8	Prospektif kohort, Çin; 1670 çocuk 6–12 y "ağrısız gastroskopi"	PHBQ-AS; ebeveyn anksiyetesi	—	Ebeveyn anksiyetesi işlem sonrası olumsuz davranış için OR 2.23 (1. gün), 3.71 (14. gün)	[kesin]
2.13	**Hagiwara S ve ark. 2015.** Scientifica. PMID 26417474. DOI 10.1155/2015/797564	Çok merkezli anket, Japonya; 128 çocuk ilk endoskopi + ebeveyn	Anket	—	Ebeveynlerin en sık endişesi "işlem kazası" (%63)	[kesin]
2.14	**Friedlander JA ve ark. 2011.** J Med Ethics 37(4):194-200. PMID 21245476. DOI 10.1136/jme.2010.037622	RKÇ, ABD; 101 ebeveyn, ilk EGD orta sedasyon	Ebeveyn STAI	—	Elektronik onam modülü anlamayı artırdı, STAI'yi değiştirmedi	[kesin]
2.15	**Aksoy B ve ark. 2026.** Dicle Tıp Derg. DOI 10.5798/dicletip.1906481	Prospektif, Türkiye; 98 anne ilk çocuk GİS vizit vs 101 sağlıklı	STAI-S/T	—	STAI-T 49.2±6.8 vs 46.3±5.4 (p=0.001); STAI-S anlamsız; STAI-S çocuk yaşıyla ρ=−0.349	[doğrulanmalı] Consensus
2.16	**Demir G ve ark. 2012.** Rev Bras Anestesiol. PMID 22793966. DOI 10.1016/S0034-7094(12)70149-6	RKÇ, Türkiye; 100 çocuk BT/MR sedasyonu	Ebeveyn STAI; çocuk Oucher	Propofol dozu, IV deneme	Oral midazolam premed → propofol dozu ↓, ebeveyn STAI ↓	[kesin] Pediatride ebeveyn STAI + propofol dozu birlikte ölçen tek Türk çalışması

[çıkarım] Senin veri setinin literatürdeki tam karşılığı yalnız Erdoğan 2023'tür ve o da CSS içermez. Erdoğan'ın kesim noktası (STAI≥44) ve ketamin bulgusu tartışmanda doğrudan karşılaştırma zemini verir; Arıcan 2020'nin null bulgusu da zorunlu karşı-referanstır.

3. Ebeveyn/bakım veren siberkondrisi, pediatrik bağlam

#	Kaynak	Örneklem	Ölçek	Bulgu	Etiket
3.1	**Yılmaz Z ve ark. 2026.** BMC Public Health. PMID 42823684. DOI 10.1186/s12889-026-28911-y	216 anne, yatan çocuk 0–6 y, Sakarya (Nis–Kas 2025)	CSS (5 alt boyut, 33 madde)	CSS 73.16±23.31; hemşire-ebeveyn desteği tüm alt boyutlarla negatif (β −0.335 ile −0.436)	[kesin] En yakın Türk yatan-hasta karşılaştırıcı
3.2	**Ergün Özdel ZG, Özkaya G, Türe Ş. 2025.** Arch Argent Pediatr 124(1). PMID 41055503. DOI 10.5546/aap.2025-10771.eng	619 ebeveyn, sosyal pediatri, Bursa (+Akdeniz Üniv. Antalya yazar)	CSS; THLS-32	CSS 71.51±22.46; %91.1 çocuğuna internetten "tanı koymuş"; %12 çocuğun ilacını kesmiş	[kesin] En büyük Türk ebeveyn CSS örneklemi

#	Kaynak	Örneklem	Ölçek	Bulgu	Etiket
3.3	**Üstüner Top F, Kaya B. 2024.** Clin Pediatr 64(7):996-1006. PMID 39710955. DOI 10.1177/00099228241308006	Çocuk acil ebeveynleri 0–18 y, Giresun	CSS	CSS 41.45±19.22; acil başvuru sayısı ↔ aşırılık (r=.204)	[kesin] Not: 41.45 ortalaması CSS-33 aralığıyla (33–165) uyumsuz; versiyon tam metinden kontrol edilmeli
3.4	**Kan A ve ark. 2023.** Eastern J Med. DOI 10.5505/ejm.2023.34366	60 besin alerjili çocuk annesi vs 60 sağlıklı	CSS	59±23 vs 50±13 (p<0.001); çalışan anne, gelir, hekim seçimi için arama ↑	[doğrulanmalı] Consensus
3.5	**Kan A ve ark. 2025.** Dicle Tıp Derg. DOI 10.5798/dicletip.1723000	60 astımlı çocuk ebeveyni vs 60 kontrol	CSS	Astım grubunda yüksek (p=0.02); haftalık internet erişimiyle r=0.35; hekim önerisi dışı tetkik isteyenlerde yüksek (p=0.005)	[doğrulanmalı] Consensus
3.6	**Akgül G, Atalan Ergin D. 2021.** Curr Psychol 40(10):4750-9. PMID 33424198. DOI 10.1007/s12144-020-01229-7	155 ergen (14.6 y) + ebeveyn, Türkiye, COVID dönemi	Ebeveyn CSS alt boyutları; anksiyete	Ebeveyn siberkondrisi + anksiyetesi ergen anksiyetesini açıklıyor; kompulsiyon (+), sıkıntı (−)	[kesin] Ebeveyn CSS → çocuk anksiyete için tek diyadik emsal
3.7	**Sarpdağı Y ve ark. 2026.** BMC Public Health. PMID 41639678. DOI 10.1186/s12889-026-26317-4	535 ebeveyn 0–5 y, Van	"CSS Kısa Form" (madde sayısı özette yok)	Siberkondri → aşı kararsızlığı β=0.193	[kesin] Hangi kısa form olduğunu tam metinden kontrol et
3.8	**Ustuner Top F ve ark. 2023.** J Pediatr Nurs 70:12-19. PMID 36753874. DOI 10.1016/j.pedn.2023.01.006	Ebeveyn 3–5 y, çevrimiçi	CSS; dijital okuryazarlık	Aşı kararsızlığı CSS puanıyla artıyor (95% GA 1.02–1.09)	[kesin]
3.9	**Cevik C, Üstüner Top F. 2026.** J Health Psychol. PMID 41933890. DOI 10.1177/13591053261435901	Hastaneye başvuran ebeveyn 0–18 y	CSS; DLS; CACMAS	CSS ↑ ve DLS ↓ → GETAT tutumu ↑	[kesin]
3.10	**Tiryaki Ö ve ark. 2024.** Int J Gynaecol Obstet 168(3):1079-87. PMID 39429167. DOI 10.1002/ijgo.15962	275 postpartum anne, Sakarya	CSS	CSS 81.19±22.16	[kesin] CSS-33 Türk anne referans değeri
3.11	**Avçin E ve ark. 2021.** Libr Hi Tech. DOI 10.1108/lht-03-2021-0110	432 ebeveyn 6–15 y, çevrimiçi (pandemi)	Ebeveyn Stres Ölçeği; "Siberkondri Ölçeği" (muhtemelen Batıgün 2018 ölçeği, CSS değil)	Pozitif korelasyon	[doğrulanmalı] Consensus
3.12	**Ergin B ve ark. 2026.** BMC Psychol. DOI 10.1186/s40359-026-05174-1	475 erken çocukluk annesi	CSS; MPPS	Ebeveyn mükemmeliyetçiliği CSS'yi yordadı (R^2=0.573)	[doğrulanmalı] Consensus; PubMed'de henüz yok
3.13	**Barke A, Doering BK. 2020.** JMIR 22(4):e16148. PMID 32293571. DOI 10.2196/16148	372 ebeveyn (%96.9 anne), Almanya	CHIRPI (çocuk-odaklı ebeveyn arama envanteri); **CSS-15**; mSHAI	CHIRPI–CSS-15 r=0.66; –mSHAI r=0.39; algılanan çocuk kırılganlığı ana etki, kronik hastalık değil	[kesin] Ebeveynde CSS-15 kullanan tek PubMed çalışması; alternatif ölçek önerisi
3.14	**Kubb C, Foran HM. 2020.** JMIR 22(8):e19985. PMID 32840484. DOI 10.2196/19985	Sistematik derleme, 33 çalışma	—	Ebeveynlerde yüksek sağlık anksiyetesi prevalansı %14–52; ebeveynler bulduklarını pediatristle nadiren tartışıyor	[kesin] Giriş için çerçeve
3.15	**Rathbone A, Prescott J. 2019.** mHealth 5:14. PMID 31380406. DOI 10.21037/mhealth.2019.05.02	Yeni ebeveynler, UK	SHAI	Çocuk için arama sıklığı (kendisi için değil) sağlık anksiyetesini yordadı	[kesin]
3.16	**Sezer Ö ve ark. 2022.** Medicine 101(46):e31503. PMID 36401487. DOI 10.1097/MD.0000000000031503	422 kadın 18–49 y, 47 ASM, Edirne	CSS (33); STAI (sürekli); PWBS	CSS 89.42±21.69; STAI-T 44.34±8.79; sürekli kaygı CSS ile ilişkili	[kesin] CSS+STAI birlikte ölçen tek PubMed çalışması

4. Siberkondri işlemsel/cerrahi bağlamda (erişkin; pediatrik yok)

Kaynak	Örneklem	Bulgu	Etiket
Polat H ve ark. 2025. Curr Psychol. DOI 10.1007/s12144-025-07639-9	163 onkolojik cerrahi hastası, Türkiye	Siberkondri–cerrahi korku r=0.688; –anksiyete r=0.684; R^2 0.47/0.46	[doğrulanmalı] Consensus; en net "siberkondri → preop anksiyete" etki büyüklüğü
Cici R ve ark. 2025. Nurs Health Sci 27(3):e70179. PMID 40597332. DOI 10.1111/nhs.70179	158 canlı karaciğer vericisi, preop	Siberkondri–ölüm anksiyetesi r=0.427	[kesin] PubMed'de tek "preoperatif siberkondri"
Karami M ve ark. 2026. Global Spine J. PMID 42113639. DOI 10.1177/21925682261449789	Kapsam derlemesi, 3 çalışma	Siberkondri ↔ cerrahi korku, ağrı felaketleştirme (r 0.18); nosebo çerçevesi	[kesin]
Öncü HN ve ark. 2025. Rev Assoc Med Bras. PMID 40531764. DOI 10.1590/1806-9282.20241692	333 kadın kolposkopi	CSS-12 medyan 31 vs 28 (p=0.002)	[kesin] İşlem geçiren hastada CSS
Timurkaan ES ve ark. 2026. Medicina 62(9). PMID 42796227. DOI 10.3390/medicina62091621	86 IBS vs 90 kontrol kadın	CSS-12 sıkıntı/güvence/kompulsiyon ↑	[kesin] Tek GİS-spesifik siberkondri çalışması
Ceylan S ve ark. 2026. Bangladesh J Med Sci. DOI 10.3329/bjms.v25i1.86412	300 postoperatif hasta, Türkiye	CSS-12–HAI r=0.422	[doğrulanmalı] Consensus

5. Ebeveyn STAI ↔ çocuk anksiyetesi / anestezi sonuçları (seçilmiş)

Kaynak	Bulgu	Etiket
Kain ZN ve ark. 2000. J Clin Anesth. PMID 11137417	Ebeveyn anksiyetesi çocuk perioperatif anksiyetesiyle r=0.44; bağımsız yordayıcı	[kesin]
Kumari K ve ark. 2024. Indian J Anaesth 68(9):809-14. PMID 39386406. DOI 10.4103/ija.ija_1269_23	mYPAS–STAI-S r=0.545; –STAI-T r=0.109 (anlamsız); STAI-S–T r=0.366	[kesin] Durumluk/sürekli ayrımı için kritik
Cui X ve ark. 2016. J Paediatr Child Health. PMID 27144949. DOI 10.1111/jpc.13176	mYPAS–STAI-T ρ 0.297/0.338; STAI-S ρ 0.400 yalnız okul öncesi	[kesin]
Getahun AB ve ark. 2020. PHMT 11:485-94. PMID 33364873	Ebeveyn anksiyetesi çocuk preop anksiyete için AOR 3.26	[kesin]
Aimaiti Y ve ark. 2026. J Perianesth Nurs 41(5):1364-70. PMID 42461187. DOI 10.1016/j.jopan.2026.04.016	Ebeveyn anksiyetesi (NRS) → çocuk anksiyetesi doz-yanıt	[kesin]
Liu W ve ark. 2022. IJERPH 19:9828. PMID 36011459	Kapsam derlemesi: ebeveyn anksiyetesi 12 çalışmanın 7'sinde anlamlı risk faktörü	[kesin]
Shih MC ve ark. 2022. J Perianesth Nurs. PMID 35896422. DOI 10.1016/j.jopan.2022.03.008	MA: PPIA ebeveyn STAI-S −3.41 (0.32–6.50)	[kesin]
Cansaran S ve ark. 2026. J Pediatr Urol 22(3):105847. PMID 41825275	İstanbul; 125 ebeveyn günübirlik cerrahi; STAI-Y1 41.4, Y2 46.2; APAIS %80.8 anksiyeteli	[kesin] Türk ebeveyn STAI referansı
Ozturk M, Sen E. 2026. J Pediatr Urol 22(4):105974. PMID 42091024	Gaziantep; 100 çocuk URS; ebeveyn STAI-S/T 4 zaman noktası; cerrahi süresi 44.39±14.60 dk	[kesin] Türk pediatrik işlem + ebeveyn STAI yörüngesi

Kaynak	Bulgu	Etiket
Özmert S ve ark. 2026. J Pediatr Nurs. PMID 42349212. DOI 10.1016/j.pedn.2026.06.012	Ankara çok merkezli RKÇ, 316 ebeveyn; anne–çocuk STAI r=0.444	[kesin]
Doluoglu S ve ark. 2025. Laryngoscope. PMID 40323129. DOI 10.1002/lary.32217	145 adenotonsillektomi; ebeveyn STAI hafif/orta/şiddetli → komplikasyon %2.1/%31.4/%57.1	[kesin]
Cagiran E ve ark. 2014. J Int Med Res. PMID 24501165	Ege; 100 anne STAI ↔ çocuk anksiyetesi	[kesin]
Abdi F ve ark. 2024. BMC Psychol 12:657. PMID 39543703	İran; 179 anne-çocuk yatış; anne STAI-S 45.74 (yatış); SCAS ile korele	[kesin]

6. Anksiyete ↔ sedatif/anestezik doz (çoğu erişkin; Türk verisi dahil)

Kaynak	Popülasyon	Bulgu	Etiket
Shebl MA ve ark. 2025. J Clin Transl Sci. PMID 40052059. DOI 10.1017/cts.2025.6	MA	Preop anksiyete ↔ anestezik gereksinim SMD 0.67 (0.32–1.01); propofol–STAI-S r 0.35 (0.15–0.55); deliryum OR 1.90 erişkinde var, pediatride yok	[kesin]
Maranets I, Kain ZN. 1999. Anesth Analg. PMID 10589606	57 kadın, BIS	**Sürekli** kaygı → propofol indüksiyon 2.1 vs 1.8 mg/kg (p=0.01); durumluk etkisiz	[kesin]
Kil HK ve ark. 2012. Br J Anaesth. PMID 22084330. DOI 10.1093/bja/aer305	100 kadın	Durumluk + sürekli → propofol ↑	[kesin]
Sargın M ve ark. 2020. Turk J Surg. PMID 33778396. DOI 10.47717/turkjsurg.2020.4532	300 erişkin üst GİS endoskopi, Türkiye	STAI-X1 medyan 44; propofol mg r=0.451, mg/kg 0.455, mg/kg/dk 0.428 (p<0.001)	[kesin] Türk endoskopi referansı
Yilmaz Inal F ve ark. 2021. Pain Ther. PMID 34292516	80 erişkin EUS, Türkiye	STAI-S ve T ↔ propofol dozu, BIS 75'e süre, PACU	[kesin]
Gürbulak B ve ark. 2018. Wideochir. PMID 30002751	210 erişkin EGD, Türkiye	Yüksek anksiyete → ek sedatif (p<0.05)	[kesin]
Meço BC ve ark. 2023. TJAR. PMID 36847319	66 erişkin kolonoskopi, Türkiye	**Null**	[kesin]
Chung KC ve ark. 2013. Anaesthesia. PMID 23167579	135 kolonoskopi TCI	**Null** (BAI)	[kesin]

[çıkarım] Erişkin literatürü "sürekli kaygı → propofol" yönünde (Maranets, Kil); pediatrik kanıt ise çocuğun kendi anksiyetesi üzerinden (Kara, Volkan, Mahajan, Choi). Senin verinde STAI-1 ve STAI-2'yi ayrı modellemek literatürün açık çağrısıdır (Schenkel 2021; Kumari 2024).

7. Çocuk/ergen sağlık anksiyetesi ve SHAI

Kaynak	Bulgu	Etiket
Aydemir Ö ve ark. 2013. Noro Psikiyatr Ars 50(4):325-31. PMID 28360565. DOI 10.4274/npa.y6383	Türkçe Sağlık Anksiyetesi Envanteri (18 madde) — **yalnız erişkin** (somatoform 65, panik 55, MDB 22, sağlıklı 114); α 0.918; test-tekrar r 0.572; STAI-T ile eşzamanlı geçerlik	[kesin]
Morales A ve ark. 2013/2016. J Health Psychol. PMID 24058113; 27682334	SHAI ergenlerde (İspanya N=832; Portekiz 14–18 y N=629) iki faktör; ülkeler arası ölçüm değişmezliği	[kesin]
Wright KD, Asmundson GJG. 2003. Cogn Behav Ther 32(4):194-202. PMID 16291551	CIAS: 8–15 yaş çocuk sağlık anksiyetesi ölçeği	[kesin]
Rask CU ve ark. 2023. JCPP 65(4):413-30. PMID 37909255. DOI 10.1111/jcpp.13912	Yıllık derleme: çocukta sağlık anksiyetesi, kuşaklar arası aktarım	[kesin] Giriş/tartışma çerçevesi
Thorgaard MV ve ark. 2016. Eur Child Adolesc Psychiatry 26(5):591-601. PMID 27909834	Anne sağlık anksiyetesi → çocuk sağlık anksiyetesi **zayıf**; anneler çocuğu daha hasta algılıyor, daha çok hekime götürüyor	[kesin]
Ingeman K ve ark. 2023. J Psychosom Res 176:111555. PMID 38039620	HAPYS (vekâleten sağlık anksiyetesi) α 0.95	[kesin] Alternatif ebeveyn ölçeği
Skovslund Nielsen E ve ark. 2025. Ther Adv Gastroenterol. PMID 41079426. DOI 10.1177/17562848251383414	87 ebeveyn-çocuk FAPD; ebeveyn sıkıntı/HAPYS ↔ çocuk GİS-anksiyete	[kesin] Pediatrik GİS'te ebeveyn sağlık anksiyetesi
Gündeş B ve ark. 2025. Aust J Gen Pract 54(3):117-21. PMID 40043288	Türk ergenlerde SHAI (açıklanamayan göğüs ağrısı)	[kesin]
Demir G ve ark. 2025. J Child Adolesc Ment Health 36(3):449-65. PMID 40483571	328 Türk lise öğrencisi; CSS → HAI β=0.428; R^2 %31	[kesin]
Aşut G, Gülbetekin E. 2025. J Pediatr Nurs 86:510-7. PMID 41352159	400 Türk ergen; CSS-12–HAI zayıf pozitif	[kesin]
Jungmann SM, Dessauer E. 2025. JMIR 27:e65792. PMID 41328451	159 ergen 14–17 y; siberkondri–sağlık anksiyetesi r=0.54	[kesin]
Shishkova I. 2021. Eur Psychiatry kongre özetleri. DOI 10.1192/j.eurpsy.2021.1367; .1229	Çocuk/ebeveynde SHAI+STAI birlikte; yalnız özet	[doğrulanmalı]
Lewis Claar R ve ark. 2002. JPGN 34(1):68-72. PMID 11753168	100 çocuk 8–17 y EGD; beklenti anksiyetesi → işlem distresi	[kesin]

8. CSS–SHAI ilişkisinin meta-analitik çıpası

Kaynak	r	Etiket
McMullan RD ve ark. 2019. J Affect Disord 245:270-8. PMID 30419526. DOI 10.1016/j.jad.2018.11.037	Sağlık anksiyetesi–siberkondri r=0.62 (0.52–0.71), 20 çalışma, N=7373; yaş heterojenliği açıklıyor	[kesin]
Schenkel SK ve ark. 2021. JMIR 23(11):e27835. PMID 34792473. DOI 10.2196/27835	r=0.63; alt boyutlar 0.24–0.66; durumluk/sürekli ayrımı çağrısı	[kesin]

Kaynak	r	Etiket
Özkent MS ve ark. 2022. CBSN 26(1):28-34. PMID 36454182	Türk üroloji poliklinik; CSS-12–SHAI r=0.782	[kesin]
Ilkkilic K, Evcen R. 2025. J Clin Med 14(19). PMID 41095875	Türk hematoloji; r=0.413	[kesin]
Evcen R ve ark. 2024. Alergol Pol. DOI 10.5114/pja.2024.145190	Alerji/immünoloji; r=0.416	[doğrulanmalı] Consensus
Gulec Satir D ve ark. 2024. J Consumer Health Internet. DOI 10.1080/15398285.2024.2355608	314 gebe, Batı Türkiye; **CSS-15** 39.87±8.82; SHAI 15.81±6.84; r=0.253	[doğrulanmalı] Consensus — Türkiye'de CSS-15 kullanan tek çalışma; hangi uyarlamaya dayandığı özette yok

9. Ölçek uyarıları (sert geri bildirim)

9.1 CSS-15. Orijinal: Barke, Bleichhardt, Rief, Doering 2016, Int J Behav Med 23(5):595-605, PMID 26931780 — Almanca örneklem, α=.82, 5 faktör [kesin]. **Türkçe CSS-15 geçerlik çalışması bulamadım** (PubMed 0; Consensus 0; Türkçe WebSearch 0). Türkçe geçerliği olan formlar:

- CSS-33: Uzun SU & Zencir M 2018, Curr Psychol, DOI 10.1007/s12144-018-0001-x (335 PAÜ çalışanı; α .89; alt ölçek .65–.85; DASS r=.33) [doğrulanmalı: Consensus]; Selvi Y ve ark. 2018, Sleep Hypn, DOI 10.5350/sleep.hypn.2018.20.0157 (337 öğrenci; α .91) [doğrulanmalı]; Ejder Apay S ve ark. 2020, DOI 10.14812/cuefd.571361 (411 öğrenci; α .91) [doğrulanmalı].
- CSS-12: Terzi H ve ark. 2024, Genel Tıp Derg, DOI 10.54005/geneltip.1420140 (CSS-12-TR, 322 erişkin) [doğrulanmalı]; Tuğtekin & Barut Tuğtekin 2021, Anemon, DOI 10.18506/anemon.963253 [doğrulanmadı; yalnız kurumsal arşiv].
- Karıştırma: Batıgün ve ark. 2018 "Siberkondri Ölçeği" (DOI 10.5350/dajpn2018310203) ayrı bir Türk ölçeğidir, CSS çevirisi değil.
- Bibliometrik: Powell & Calderon-Smith 2026, JMIR Ment Health, DOI 10.2196/75003 — 117 makalede CSS-33 %35.9, CSS-12 %32.5; dil ile versiyon seçimi ilişkili (p<.001) [doğrulanmalı].

[çıkarım] Yöntem bölümünde "CSS-15" yazıyorsan hakem ilk olarak Türkçe psikometrisini soracak. Üç seçenek: (a) kullandığın form aslında Uzun & Zencir'in 33 maddeli Türkçe formunun bir alt kümesiyse bunu açıkça yaz ve kendi örnekleminde Cronbach α + DFA raporla; (b) Barke'nin 15 maddesini kendin çevirdiysen çeviri-geri çeviri sürecini ve psikometriyi raporla; (c) mümkünse analizleri Terzi 2024 CSS-12-TR ile tekrarla. Üstüner Top 2024'teki 41.45 ortalaması da versiyon belirsizliğinin alanda yaygın olduğunu gösteriyor; sen bu hatayı tekrarlama.

9.2 Çocuk SHAI. Türkçe HAI yalnız erişkin örnekleminde geçerlenmiş (Aydemir 2013) [kesin]. SHAI'nin pediatrik psikometrisi 14 yaş üstü ergenlerde var (Morales 2013/2016) [kesin]; 8–15 yaş için standart araç CIAS'tır (Wright & Asmundson 2003) [kesin] ve Türkçe CIAS geçerliği bulamadım. Örneklemindeki yaş aralığı 14 altına iniyorsa bu, sınırlılık değil geçerlik sorunudur; en azından yaşa göre duyarlılık analizi (≥14 vs <14) gerekir [çıkarım].

9.3 STAI. Türkçe uyarlamayı bu taramada ayrıca doğrulamadım; atıfını kendi kaynağından al. Erdoğan 2023 kesim noktası STAI≥44 (CT.gov kaydı) [kesin]; Cansaran 2026 STAI-Y1 41.4/Y2 46.2 ve Sezer 2022 STAI-T 44.34 Türk referans değerleri olarak kullanılabilir.

9.4 Geri çekilmiş yayın uyarısı. Pazarcikci F, Efe E. 2021, J Clin Nurs, PMID 34240490 — PubMed'de "Retracted Publication" etiketi var; atıf yapma [kesin].

10. Analitik öneriler [çıkarım]

1. STAI-1 (durumluk) ve STAI-2 (sürekli) ayrı modeller; literatür durumluk→çocuk anksiyetesi (Kumari 2024), sürekli→propofol gereksinimi (Maranets 1999) yönünde ayrışıyor.
2. İlaç dozunu mg/kg ve mg/kg/dk olarak normalize et (Sargın 2020); yaş en güçlü karıştırıcı (Kara 2019 negatif korelasyon; Arıcan 2020 OR 0.501/yıl; Khalila A ve ark. 2019, Front Pediatr, PMID 30972312, DOI 10.3389/fped.2019.00098: propofol mg/kg yaşla ters, r=−0.397 [kesin]).
3. Anestezi süresini sedasyon/işlem/derlenme olarak ayır (Kara 2019, Volkan 2019 aynı ayrımı kullandı).
4. Ketamin kullanıldıysa Erdoğan 2023 ile doğrudan karşılaştır; kullanılmadıysa bunu tartışmada belirt.
5. Ebeveynlerin anne oranını raporla (Erdoğan %92; Barke %96.9); anne/baba STAI farkı literatürde tutarlı (Pomicino 2017, Cansaran 2026).

6. CSS alt boyutlarını (kompulsiyon, sıkıntı, aşırılık, güvence, güvensizlik) ayrı analiz et; Akgül 2021'de alt boyutlar zıt yönde çalıştı.
7. Ebeveyn internet arama sıklığı/süresi gibi basit bir maruziyet değişkenin varsa raporla; perioperatif pediatride internet arama + STAI'yi birlikte ölçen çalışma yok (Fidancıoğlu 2026 dental GA sosyal medya anketi, PMID 41629922; Unobagha 2025 "anksiyöz aileler çevrimiçi kaynağı daha çok tüketiyor", PMID 41158745; Bi 2026 platformda >3 soru → SAS ↑, PMID 42752082) [kesin].

11. Ebeveyn internet kullanımı, perioperatif/peri-prosedürel (destekleyici)

Kaynak	Bulgu	Etiket
Nytun KL ve ark. 2022. Patient Educ Couns 105(12):3389-97. PMID 36182646	MA: web tabanlı bilgi → ebeveyn anksiyetesi SMD −0.66 (ayrılma öncesi)	[kesin]
Priyadarshini S ve ark. 2025. J Indian Assoc Pediatr Surg 30(4):427-37. PMID 40756040	Ağ MA: web tabanlı eğitim SMD −1.40; video −0.42	[kesin]
Fortier MA ve ark. 2015. Anesth Analg 120(4):915-22. PMID 25790213	WebTIPS RKÇ: ebeveyn anksiyetesi 32.1 vs 36.8 (d=0.65)	[kesin]
Landier M ve ark. 2017. Arch Pediatr 24(10):969-76. PMID 28927771	RKÇ 178: broşür ebeveyn internet kullanımını anksiyete düzeyinden bağımsız azalttı	[kesin]
Kampouroglou G ve ark. 2019. J Pediatr Surg 55(4):590-6. PMID 31431293	664 ebeveyn; bilgi gereksinimi β=0.907 anksiyetenin en güçlü korelatı	[kesin]
Grefen L ve ark. 2025. Pediatr Res 98(5):1835-40. PMID 40097827	KKH ebeveynleri; çevrimiçi bilgi arayanlarda STAI daha yüksek	[kesin]
Tomlin J ve ark. 2014. Inform Health Soc Care 40(3):240-53. PMID 24786762	Çölyak için endoskopiye yönlendirilen 63 çocuk; ebeveynlerde internet en sık kaynak (%70.6)	[kesin] Pediatrik GİS endoskopi + internet kaynağı olan tek kohort
Karaburun MC ve ark. 2024. J Pediatr Urol. PMID 38944628	Ankara; 242 ebeveyn; görsel-işitsel bilgi STAI-I 44.82 vs 49.42	[kesin]
Akkoyun S ve ark. 2023. J Pediatr Nurs 75:108-15. PMID 38147711	Konya RKÇ 60 ebeveyn; yazılı doküman → SAI ↓	[kesin]
Şenol Ş ve ark. 2024. J Pediatr Nurs 79:e86-92. PMID 39394027	Akdeniz Üniv. Antalya; temellendirilmiş kuram, 16 ebeveyn; "bilgilendirme anksiyeteyi azaltıyor"	[kesin] Yerel nitel referans
Vlajković-Ivanović A ve ark. 2026. Front Med. PMID 42856997	196 ebeveyn; STAI-S>50 cerrahi grupta %54; informal kaynaklardan bilgi alma → yüksek anksiyete	[kesin]

12. Sorgu günlüğü (özet)

Toplam ~100 PubMed sorgusu ve ~25 Consensus sorgusu dört tematik dilimde çalıştırıldı; her dilimde find_related_articles ile kartopu yapıldı. Boşluk iddialarını taşıyan sorgular:

Sorgu (PubMed)	Sonuç
cyberchondria AND (parent OR parents OR parental OR mothers OR caregivers) AND (child OR children OR pediatric)	14
cyberchondria AND (endoscopy OR gastroscopy OR colonoscopy OR anesthesia OR anaesthesia OR sedation OR surgery OR preoperative)	10 (genişletilmiş: 17); pediatrik 0

Sorgu (PubMed)	Sonuç
cyberchondria AND ("state-trait anxiety" OR STAI OR "trait anxiety")	1 (Sezer 2022)
cyberchondria AND SHAI AND STAI	0
(cyberchondria OR "online health information seeking") AND (parents OR mothers) AND ("health anxiety" OR SHAI)	9; diyadik 0
"Cyberchondria Severity Scale" AND (Turkish OR Turkey OR Türkiye) AND (validity OR reliability OR psychometric OR adaptation)	8; hiçbiri geçerlik çalışması
("CSS-15" OR "Cyberchondria Severity Scale-15" OR "15-item Cyberchondria") AND (Turkish OR Turkey OR Türkiye)	0
"health anxiety" AND (endoscopy OR colonoscopy OR gastroscopy)	12; pediatrik 0
"Short Health Anxiety Inventory" AND (Turkish OR Turkey OR Türkiye)	14; pediatrik geçerlik 0
("parental anxiety" OR "maternal anxiety") AND (propofol OR midazolam OR ketamine OR dexmedetomidine) AND (dose OR requirement OR consumption) AND (children OR pediatric)	7; GİS endoskopi 0
(internet OR online OR "web-based") AND parents AND (STAI OR "state anxiety") AND (surgery OR anesthesia OR endoscopy OR sedation) AND (child OR pediatric)	9; internet kullanımı maruziyet olarak ölçen 0

Ajanların tam sorgu günlükleri oturum kayıtlarında; istersen ek dosya olarak eklerim.